ATP | MÓDULO E3M40 | FUNCIONALIDADE III, COGNIÇÃO E HUMOR

Gabarito docente

Risco de suicídio: avaliação e conduta

Prof. João Frederico Musial
Medicina | Campo Real | 2026

ATP "Risco de Suicídio: avaliação e conduta". Módulo E3M40, Funcionalidade III, Cognição e Humor. Medicina, Centro Universitário Campo Real, 2026.

Como usar este gabarito

O que segue não é a resposta certa. É o conjunto de formulações que um grupo pode sustentar com os fatos do dossiê, mais o que a leitura do caso não autoriza. O critério de correção é a coerência entre dados, formulação, decisão, segurança e continuidade, e não a coincidência com o que está escrito aqui. Uma conclusão diferente da prevista é aceitável quando os fatos existem no caso, nada foi inventado, a inferência está explicitada, a conduta é defensável, o grupo reconhece as limitações e a segurança foi concretamente considerada.

A pergunta que organiza toda a correção é a mesma da aula: é possível construir segurança suficiente fora de um ambiente protegido neste momento? Um grupo que responde essa pergunta com os dados do caso acertou o exercício, mesmo que a resposta difira da que está aqui.

O erro transversal a nomear na plenária, em qualquer caso: transformar dado isolado em decisão.

Caso 1, grupo 1

Formulação defensável

Mulher de 38 anos em episódio depressivo maior de sete meses, em tratamento iniciado recentemente, com piora sintomática nas últimas três semanas, que apresenta ideação suicida diária, passiva e intrusiva, sem intenção atual estabelecida, sem plano e sem qualquer comportamento preparatório. A capacidade de afastar o pensamento está preservada e é sensível ao contato com a irmã. Procura ajuda por iniciativa própria, informa a família, aceita a participação dela e sustenta um plano combinado. O que a protege agora não é a ausência da ideação, que é diária, mas a combinação de baixa mobilização para a ação com alta capacidade de colaborar.

Elementos que sustentam a formulação

Procura espontânea, no mesmo dia em que o sofrimento apertou. Ideação descrita como matinal, com afastamento possível. Ausência explícita de plano, negada de forma espontânea e com desconforto próprio. Ausência de comportamento preparatório em qualquer momento. Revelação prévia à irmã, feita pela própria paciente na noite anterior. Aceitação imediata de incluir a irmã na conversa. Resposta concreta e verificável à pergunta sobre o que faria se piorasse. Ausência de intoxicação, psicose, agitação e mudança recente de tratamento.

Elementos que não decidem sozinhos

A frase ”tenho pensado em morrer todos os dias” não decide nada, e é exatamente a mesma do caso 2. O diagnóstico de depressão maior não decide. A ausência de tentativa prévia não decide, e é o fator de risco cuja ausência mais frequentemente é usada para tranquilizar indevidamente. A presença de acompanhante não decide, porque a mesma acompanhante está presente no caso 2. A desesperança, presente e marcada, também não decide, porque está igualmente presente no caso 2.

Ausências plantadas e como percebê-las

Não foi perguntado sobre arma de fogo na residência. O aluno deve perceber porque o atendimento chega a discutir segurança da casa e nunca nomeia o que há nela. Não foi levantado o que existe de medicação em casa e quem guarda, embora a conduta combinada dependa disso. Não há informação sobre as últimas 48 horas de sono, apesar de o dossiê registrar sono fragmentado e piora de três semanas. Não há história familiar de suicídio, embora a história clínica cubra todo o resto. Não se sabe se há consulta ambulatorial marcada, embora a continuidade seja o desfecho pedido. O aluno percebe essas ausências pela assimetria: o dossiê é detalhado em tudo o que não decide e silencioso justamente onde a conduta precisa apoiar-se.

Condutas defensáveis

Manejo ambulatorial com segurança construída na própria consulta. Restrição de acesso a meios pactuada com a paciente e com a irmã, em conversa conjunta e com combinação concreta de quem faz o quê e até quando. Plano de segurança escrito com a paciente, em seus próprios termos, com sinais de alerta, estratégias que ela já usa, pessoas e ambientes que ajudam, quem ela aciona, serviços e horários. Revisão do tratamento do episódio, incluindo a avaliação de resposta às seis semanas de sertralina e a discussão de psicoterapia, que nunca foi feita. Seguimento com data, local, profissional responsável, via de contato e conduta definida em caso de piora. Contato ativo do serviço nas próximas 48 a 72 horas.

Condutas inadequadas

Alta com ”retorne se piorar”. Contrato de não suicídio no lugar do plano de segurança. Prescrição de benzodiazepínico como resposta principal ao caso. Encaminhamento ambulatorial sem data. Internação pelo conteúdo da fala, sem que a formulação a sustente. Dizer à irmã apenas que ”está tudo bem” sem organizar com ela nada concreto.

Erro previsível

O grupo classificará o caso como risco baixo e tratará a conclusão como se o problema estivesse resolvido, reduzindo a conduta a um encaminhamento. O segundo erro previsível é o oposto: impressionar-se com o ”todos os dias” e propor internação sem conseguir dizer o que a internação resolveria que a casa com a irmã não resolve.

Pergunta para a defesa

O que exatamente, neste caso, permite a vocês construírem segurança fora de um ambiente protegido, e o que precisaria mudar hoje à noite para que essa resposta se invertesse?

Caso 2, grupo 2

Formulação defensável

Mulher de 38 anos, com a mesma queixa, o mesmo diagnóstico, o mesmo tempo de doença e o mesmo tratamento da paciente do caso 1, que apresenta ideação suicida diária persistente, plano definido que ela se recusa a detalhar, acesso disponível em casa confirmado por ela e comportamento preparatório concreto e datado na semana anterior. Oculta a situação da família, inclusive tendo dado à irmã uma explicação falsa para a consulta, e recusa tanto a participação da irmã quanto qualquer combinação sobre o que fará se piorar. A suicidalidade aqui não é mais grave por ser mais sofrida, e sim por já ter se convertido em ato preparatório uma vez, e porque a rede que existe está deliberadamente fora do circuito.

Elementos que sustentam a formulação

Plano existente e reconhecido. Acesso confirmado no momento presente. Comportamento preparatório recente, datado e interrompido pela própria paciente, o que indica mobilização para a ação e não apenas pensamento. Ocultação ativa, com informação falsa dada à acompanhante. Recusa de participação da rede. Recusa de pactuar conduta para o agravamento. Juízo crítico parcial quanto à necessidade de medida.

Elementos que não decidem sozinhos

A frase de abertura, idêntica à do caso 1. O diagnóstico, idêntico. A ausência de tentativa prévia, idêntica. A presença da irmã na sala de espera, idêntica. O contato reduzido e a pouca modulação do afeto são sinais de dificuldade de engajamento, não são por si o fundamento da decisão, e um grupo que decidir só por eles decidiu por impressão.

Ausências plantadas e como percebê-las

As mesmas do caso 1, deliberadamente. Não foi perguntado sobre arma de fogo, apesar de a paciente ter confirmado acesso ao que usaria, o que torna a omissão mais grave aqui do que ali. Não se sabe o que há de medicação em casa. Não se sabe o que exatamente foi dito à irmã. Não se sabe se há consulta marcada. O aluno percebe comparando: o dossiê é o mesmo do caso 1 em tudo o que não decide, e o que falta é sempre o que permitiria construir a restrição de acesso.

Condutas defensáveis

Não liberar a paciente sem que a segurança tenha sido construída de fato, o que neste momento não é possível apenas com a conversa, porque ela recusa a rede e recusa pactuar. Permanência em observação enquanto a situação é trabalhada, com reavaliação em curto intervalo. Trabalho ativo sobre a recusa, nomeando com ela por que a irmã precisa saber e o que exatamente seria dito, buscando consentimento antes de qualquer quebra. Se a recusa se mantiver e a formulação permanecer, comunicação proporcional à necessidade de proteção, informando a paciente do que será dito e a quem, e registrando a justificativa. Restrição de acesso a meios como objetivo concreto, com participação da irmã. Se a segurança não puder ser construída, indicação de ambiente protegido, com laudo circunstanciado, e internação involuntária se ela recusar, com comunicação ao Ministério Público em 72 horas pelo responsável técnico. Revisão do tratamento do episódio.

Condutas inadequadas

Aceitar a recusa da paciente como se encerrasse a discussão. Liberar com plano de segurança que só existe no papel, porque nenhuma das pessoas que o executariam sabe dele. Acionar internação compulsória, que é judicial e não é a via da urgência. Prometer sigilo absoluto antes de saber o que será dito. Reduzir a conduta ao ajuste da sertralina. Registrar apenas ”paciente nega intenção”.

Erro previsível

O grupo dirá que o caso 2 é mais grave ”porque ela está pior”, sem conseguir nomear o que mudou. A tarefa da plenária é obrigar o grupo a apontar os três elementos, preparação, ocultação e capacidade de colaborar, e perceber que tudo o mais é igual.

Pergunta para a defesa

Se a fala, o diagnóstico, o tempo de doença, a medicação e a acompanhante são os mesmos do grupo 1, o que exatamente mudou a conduta de vocês, e em que ponto da entrevista isso apareceu?

Caso 3, grupo 3

Formulação defensável

Homem de 29 anos com transtorno bipolar tipo I em episódio misto, com redução importante de sono há três semanas, disforia, irritabilidade, aceleração, impulsividade e decisão abrupta recente de grande impacto. A ideação suicida é flutuante, intensa quando presente e sem planejamento, e o próprio paciente descreve perda de controle sobre o intervalo entre pensar e agir. Dois modificadores proximais dominam a formulação: a suspensão abrupta do lítio há sete meses e o uso de antidepressivo isolado há quatro meses em transtorno bipolar, além do episódio de saída noturna de casa sem aviso. O risco aqui não está na profundidade do desânimo e sim na combinação de sofrimento com energia, impulsividade e insônia.

Elementos que sustentam a formulação

Episódio misto caracterizado, com energia aumentada apesar do sofrimento. Sono de cerca de duas horas há três semanas. Impulsividade documentada por ato, a demissão por telefone de madrugada. Comportamento noturno de saída sem aviso na véspera. Ideação que vem ”inteira” e sobre a qual ele diz não confiar em si à noite. Juízo crítico comprometido quanto à gravidade. Tentativa prévia em episódio anterior. Duas internações prévias com padrão prodrômico igual ao atual, reconhecido pela esposa. Ausência de supervisão contínua a partir da próxima segunda-feira.

Elementos que não decidem sozinhos

A ausência de plano estruturado. O fato de a ideação ”passar”. A presença da esposa, que está disponível agora e não estará em três dias. O diagnóstico de transtorno bipolar por si só. A ausência de tristeza contínua, que é justamente a pista que faz o aluno subestimar o caso.

Ausências plantadas e como percebê-las

Não foi perguntado sobre arma de fogo nem sobre acesso por meio do trabalho, apesar de ele ser técnico em edificações e de a impulsividade ser o eixo do caso. Não se sabe o que aconteceu nas horas em que ele esteve fora de casa, embora esse seja o comportamento recente mais relevante do dossiê e o médico tenha mudado de assunto logo depois. Não se sabe sobre uso recente de álcool ou substâncias, apesar de impulsividade e insônia. Não se sabe como terminou a última internação. Não se sabe quem poderá ficar com ele na semana da viagem, embora a conduta dependa disso. O aluno percebe pelo corte da entrevista: há uma pergunta iniciada e não concluída.

Condutas defensáveis

Tratar o episódio misto como a prioridade, o que inclui reavaliar a manutenção do antidepressivo isolado e reintroduzir estabilização, com o lítio como opção que tem evidência específica de redução de suicídio em transtornos do humor, sem apresentá-lo como resgate imediato de uma crise. Tratar a insônia como alvo, não como sintoma acessório. Restrição de acesso a meios organizada com a esposa. Plano de segurança que leve em conta que ele mesmo diz não confiar em si à noite. Definição explícita de quem fica com ele a partir da segunda-feira, antes da alta, e não como recomendação genérica. Reavaliação em prazo curto, com janela de vigilância declarada por mudança de tratamento. Observação em serviço ou ambiente protegido se a supervisão não puder ser garantida ou se a agitação e a insônia não cederem.

Condutas inadequadas

Manter antidepressivo isolado sem discussão. Prescrever apenas indutor de sono e liberar. Concluir que não há risco porque não há plano. Liberar com a esposa como garantia, sem verificar que ela viaja em três dias. Encaminhar para ambulatório em trinta dias. Reintroduzir lítio sem exames e sem definir quem acompanha.

Erro previsível

O grupo procurará o deprimido retraído, não o encontrará, e concluirá que o risco é menor do que no caso 1. O segundo erro previsível é transformar o caso em discussão de psicofarmacologia e não entregar decisão de ambiente nem plano concreto para a noite.

Pergunta para a defesa

Qual é o modificador proximal que mais pesa aqui, e o que a conduta de vocês faz com ele nas próximas 24 horas?

Caso 4, grupo 4

Formulação defensável

Mulher de 22 anos com transtorno de personalidade borderline, em crise de desregulação após ruptura afetiva há três dias, com autolesão recente sem intenção suicida, ideação suicida flutuante e ambivalente, e um episódio de mobilização real na madrugada de anteontem, quando permaneceu diante de um meio disponível e interrompeu o movimento buscando contato. A rede próxima está em erosão, com a amiga de saída da cidade e a mãe exausta e descrente. O risco de repetição do padrão é crônico e elevado, e há

um componente agudo em cima dele. A questão não é se ela ”vai fazer de novo”, e sim se há alguém que a receba amanhã, não daqui a dois meses.

Elementos que sustentam a formulação

Ruptura recente, que é o precipitante típico do padrão dela. Mobilização documentada na madrugada de anteontem, com meio disponível e interrupção por contato. Autolesão recente, que ela mesma descreve com função de regulação e não de morte, e que é marcador de risco futuro ainda assim. Tentativa prévia aos 19 anos. Rede em colapso, com a amiga saindo e a mãe esgotada. Quatro passagens pela unidade em doze meses sem que o seguimento se estabelecesse. Pedido explícito de continuidade próxima, feito por ela.

Elementos que não decidem sozinhos

O diagnóstico de borderline, que não é razão para desqualificar a apresentação. A autolesão, que não é tentativa de suicídio e também não é irrelevante para o risco. A frase ”eu não quero morrer”, dita hoje, que não cobre a madrugada de anteontem. A repetição do padrão, que reduz a surpresa e não reduz o risco. O cansaço da mãe, que é dado sobre a rede e não sobre a paciente.

Ausências plantadas e como percebê-las

Não se sabe o que estava no armário nem se é possível combinar restrição, embora esse seja o único momento do caso em que houve meio disponível e proximidade da ação. Não foi perguntado sobre arma de fogo. Não se sabe o que aconteceu nas três passagens anteriores pela unidade nem o que já foi tentado, embora o dossiê afirme que o seguimento nunca se estabeleceu. Não se sabe se houve álcool nos três dias. Não se sabe o que a mãe consegue sustentar. O aluno percebe porque o dossiê registra a existência das passagens anteriores e não o conteúdo delas, que é justamente o que evitaria repetir a conduta que já falhou três vezes.

Condutas defensáveis

Manejo ambulatorial com continuidade real e próxima, em 24 a 72 horas, com nome, local e via de contato, e não encaminhamento genérico. Validação explícita do sofrimento, com distinção nomeada entre autolesão e tentativa, dita à paciente e dita à mãe. Plano de segurança construído com ela, usando as estratégias que já funcionaram, incluindo o contato que interrompeu a madrugada de anteontem. Restrição de acesso ao que estava no armário, pactuada. Conversa separada com a mãe, orientando sobre o que é e o que não é a autolesão e sobre o que se espera dela concretamente nos próximos dias, sem transferir a vigilância integral. Encaminhamento para psicoterapia estruturada como objetivo de médio prazo, reconhecendo a barreira de custo e agenda que já interrompeu o tratamento uma vez. Revisão do uso irregular de fluoxetina. Observação em serviço se a noite não puder ser organizada.

Condutas inadequadas

Internar para ”resolver de uma vez”, que é o que a mãe pede e não é o que o caso indica, salvo se a segurança não puder ser construída. Alta sem data de seguimento, repetindo pela quarta vez o que já falhou. Registrar ”sem risco, quadro de personalidade”. Prescrever benzodiazepínico em quantidade livre como resposta à angústia. Tratar a autolesão como manipulação. Tratar a autolesão como tentativa de suicídio e conduzir o caso por essa equivalência.

Erro previsível

O grupo se dividirá entre desqualificar, com alguma variação de ”é borderline, faz sempre”, e superproteger, internando por segurança própria. O erro mais fino, e o mais comum entre alunos bem intencionados, é acertar a formulação e entregar uma continuidade que é indistinguível das três que já falharam.

Pergunta para a defesa

O que a conduta de vocês faz de diferente do que já foi feito nas três passagens anteriores, e por que isso mudaria o desfecho?

Caso 5, grupo 5

Formulação defensável

Homem de 45 anos, sem avaliação psiquiátrica prévia, trazido em intoxicação aguda por álcool após verbalização suicida pública e saída de casa em contexto de conflito. A avaliação atual está comprometida pelo estado mental: as informações são contraditórias, o afeto oscila dentro do mesmo atendimento e o juízo crítico está prejudicado, de modo que nem a afirmação nem a negação feitas agora podem ser tomadas como definitivas. Há modificadores proximais relevantes e independentes da intoxicação: separação recente, perda de trabalho, uso diário e solitário de álcool nas últimas semanas, isolamento e um comportamento novo apontado pelo próprio irmão. A rede existe e não é segura esta noite. A decisão correta agora não é decidir, e sim observar e reavaliar sóbrio.

Elementos que sustentam a formulação

Intoxicação em curso, com sonolência oscilante e desorientação parcial em tempo. Relato por terceiro de verbalização suicida com saída de casa, comportamento descrito como novo pelo irmão. Contradição interna do relato dentro do mesmo atendimento. Uso diário e solitário de álcool nas últimas semanas. Separação há cinco meses e queda de trabalho. Ausência de qualquer avaliação prévia que sirva de linha de base. Cuidador disponível que também bebeu e que sai às cinco da manhã.

Elementos que não decidem sozinhos

A negação atual, feita em intoxicação. A afirmação atual, feita em intoxicação. A presença do irmão, que é rede e não é supervisão. A ausência de tentativa prévia, em alguém que nunca foi avaliado e sobre quem não existe registro. A frase ”amanhã eu não penso”, que é previsão do paciente sobre si mesmo em estado alterado.

Ausências plantadas e como percebê-las

Não foi perguntado sobre arma de fogo, o que neste caso é falha grave e não apenas lacuna, porque há intoxicação, impulsividade e conflito. Não se sabe o que foi dito na discussão nem diante de quem. Não se sabe o padrão de uso nem a última dose. Não se sabe se já houve episódios semelhantes e como terminaram. Não se sabe como ele se apresenta sóbrio, e o dossiê declara que não existe prontuário prévio, o que torna a ausência visível. O aluno percebe porque o dossiê informa que ele nunca foi avaliado e, ao mesmo tempo, exige uma decisão sobre ele.

Condutas defensáveis

Permanência em observação até a resolução da intoxicação, com reavaliação do estado mental sóbrio antes de qualquer decisão sobre disposição. Cuidado clínico da intoxicação, com atenção a hipoglicemia, trauma e abstinência. Segurança ambiental no serviço enquanto permanece. Coleta de informação colateral com o irmão e com o vizinho, enquanto ele dorme, sobre arma, padrão de uso e episódios anteriores. Reavaliação formal sóbrio, com a mesma sequência de perguntas da aula. Somente então, decisão sobre disposição, com plano de segurança, restrição de acesso, encaminhamento para cuidado do uso de álcool e seguimento com data. Se a reavaliação sóbrio mantiver a suicidalidade e a supervisão noturna não existir, ambiente protegido.

Condutas inadequadas

Liberar porque ele negou agora. Liberar aos cuidados do irmão que também bebeu e que sai de madrugada. Concluir que não é possível avaliar alguém alcoolizado e, por isso, não avaliar nada, deixando de colher colateral e de garantir segurança no intervalo. Indicar internação psiquiátrica involuntária durante a intoxicação sem reavaliação, como se o estado atual fosse o quadro. Prescrever benzodiazepínico e liberar. Registrar apenas ”etilismo agudo, orientado e liberado”.

Erro previsível

O grupo se dividirá entre ”alcoolizado não pode ser avaliado”, que paralisa, e ”ele negou, então está resolvido”, que libera. Os dois erros têm a mesma raiz, que é tratar a avaliação como evento único em vez de processo com reavaliação.

Pergunta para a defesa

O que exatamente vocês farão nas próximas quatro horas, e o que precisa estar diferente para que a decisão sobre ele sair daqui possa ser tomada?

Caso 6, grupo 6

Formulação defensável

Homem de 24 anos em primeiro episódio psicótico, com delírio persecutório sistematizado, alucinação auditiva imperativa que ele se recusa a detalhar, medo intenso, juízo crítico ausente e deterioração funcional de dois meses. Nega ideação suicida quando perguntado diretamente, mas enuncia, dentro do sistema delirante, a ideia de que desaparecer protegeria a avó, o que é conteúdo de risco ainda que não se apresente como desejo de morrer. A capacidade de participar da própria segurança está comprometida pelo próprio quadro: ele não confia no telefone, não confia no médico e não consegue combinar com a avó. O suporte disponível é uma senhora de 78 anos com limitação de marcha, sem transporte e sem rede. A segurança aqui não pode ser construída com um plano que depende de colaboração e de comunicação.

Elementos que sustentam a formulação

Alucinação imperativa presente, recente, e recusa de detalhar o conteúdo, o que impede avaliar o que exatamente está sendo comandado. Delírio persecutório com ideia de que o desaparecimento dele protege a avó. Juízo crítico ausente. Desconfiança que inviabiliza o plano de segurança, incluindo a recusa de

usar telefone e de falar com a avó. Deterioração funcional de dois meses, com restrição alimentar por conteúdo delirante e faltas ao trabalho. Suporte único com limitação física e sem alternativa. Medicações de terceiros guardadas na casa sem controle.

Elementos que não decidem sozinhos

A negação explícita de querer morrer, que é exatamente a armadilha do caso. A ausência de tentativa prévia, em alguém de 24 anos em primeiro episódio. O fato de ele ter aceitado vir à unidade. A ausência de agitação no momento da consulta. O primeiro episódio como tal, que é, ao contrário, período de risco elevado.

Ausências plantadas e como percebê-las

O conteúdo da voz imperativa foi recusado e não foi retomado, e essa é a ausência central do caso: o dossiê registra a recusa e registra que o examinador seguiu adiante. Não foi perguntado sobre arma de fogo. Não se sabe quais medicações da avó estão em casa, embora o dossiê informe que existem e que não há controle. Não se sabe sobre uso de substâncias, apesar de primeiro episódio aos 24 anos. Não se sabe há quanto tempo ele não dorme nem se houve restrição de água, apesar da restrição alimentar declarada. O aluno percebe porque cada uma dessas informações aparece pela metade no dossiê.

Condutas defensáveis

Não liberar. O paciente não consegue participar da própria segurança, o suporte disponível não sustenta supervisão e há conteúdo imperativo não caracterizado. Permanência em ambiente protegido, com indicação de internação, laudo circunstanciado que exponha os motivos, e modalidade definida pelo consentimento: voluntária se ele aceitar, involuntária se recusar, com comunicação ao Ministério Público em 72 horas pelo responsável técnico do estabelecimento e repetição da comunicação na alta. Tratamento do quadro psicótico iniciado, com atenção a que redução de sintoma não é, por si, garantia de segurança. Retomada da caracterização da voz imperativa quando houver vínculo suficiente. Restrição de acesso às medicações da casa, organizada com a avó. Segurança ambiental e supervisão enquanto aguarda vaga, incluindo a decisão sobre remoção e o que informar à regulação na sequência fixa. Contenção apenas se houver risco imediato, com indicação, prescrição, monitorização e registro. Orientação e suporte à avó, que é cuidadora única e idosa.

Condutas inadequadas

Liberar porque ele negou querer morrer. Liberar aos cuidados da avó. Prescrever antipsicótico e marcar retorno ambulatorial. Acionar internação compulsória, que é judicial e não é a via da urgência. Conter de rotina, sem indicação, prescrição e registro. Prometer à avó que não se dirá nada a ninguém. Registrar ”nega ideação suicida” como conclusão da avaliação de risco.

Erro previsível

O grupo tomará a negação explícita como resposta e centrará a discussão no diagnóstico do quadro psicótico, deixando a decisão de segurança implícita. O segundo erro previsível é acertar a indicação de ambiente protegido e não saber nomear a modalidade, confundindo involuntária com compulsória.

Pergunta para a defesa

Ele diz que não quer morrer. Por que vocês não aceitaram essa resposta, e que informação vocês teriam buscado antes de decidir?

Roteiro da plenária por pares

Pares 1 e 2

Pergunta: se a frase e o diagnóstico eram os mesmos, o que realmente separou as duas condutas? Conduzir até que os três elementos sejam nomeados: comportamento preparatório, ocultação e capacidade de colaborar com a própria segurança. Explicitar que idade, sexo, profissão, tempo de doença, medicação, acompanhante e desesperança eram idênticos, e que qualquer grupo que tenha decidido por um desses decidiu por um dado que não distinguia nada.

Pares 3 e 4

Pergunta: que erro aparece quando o diagnóstico substitui a formulação? No grupo 3, o diagnóstico de transtorno bipolar convida a procurar o deprimido retraído, e o risco está no estado misto. No grupo 4, o diagnóstico de borderline convida a desqualificar, e o risco está na combinação de cronicidade com um episódio agudo de mobilização. Nos dois, o rótulo diagnóstico é usado como se contivesse a conduta.

Pares 5 e 6

Pergunta: o que muda quando o paciente não consegue participar plenamente da própria segurança? No grupo 5 a incapacidade é transitória e a resposta é tempo e reavaliação. No grupo 6 a incapacidade é do próprio quadro e a resposta é ambiente. O aprendizado é que a capacidade de colaborar é elemento da formulação e não um detalhe de execução do plano.

Fechamento

Risco não é etiqueta. A mesma fala não significa o mesmo risco. O mesmo diagnóstico não produz a mesma conduta. Uma boa avaliação termina em decisão de segurança.